SDD 64 Sujet n°1

Spécialité : ORL

Date : 07/10/2023
Auteur : SHARPIN-GUION Marion, ELAYLI Robin (DES Psychiatrie Grenoble, ECN 2023)
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial (DES MAR, EN 2023/2024)

Situation de départ	SDD 226 - découverte d'anomalie à l'imagerie cérébrale
Objectif de connaissance	Item 091 Déficit neurologique récent Item 169 Infection à VIH
Attendu d'apprentissage spécifique Attendu d'apprentissage dans la famille	Synthèse des examens paracliniques
Contexte	Patient de 25 ans avec signes de focalisation fébrile consulte au SAU
Département d'enseignement	examen paraclinique
Auteur	MOULIN Maïla, DANG-TRUNG Antoine (11/05/2024)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Vous êtes interne aux urgences et vous recevez M. P., 25 ans, présentant un déficit neurologique d'apparition récente dans un contexte de fièvre depuis quelques jours.

Votre externe a commencé l'observation médicale.

Un examen d'imagerie et un bilan biologique ont été réalisés

Vous avez 8 minutes pour :

- Analyser et interpréter l'iconographie et le bilan biologique
- Énoncer votre principale hypothèse diagnostique en justifiant
- Proposer une prise en charge diagnostique et thérapeutique

Vous ne devez pas :

- examiner le patient
- interroger de patient.

Il s'agit d'une station sans PS et sans PSS.

Observation médicale faite par votre externe

Identité : M. P., 25 ans.

Mode de vie :
Étudiant en pharmacie.
Vit avec sa mère et sa sœur à Paris en appartement.
2 chats.
Nombreux partenaires sexuels.
Consommation tabagique chronique : 7 PA.
Consommation alcoolique : occasionnel
Autres drogues : consommation d'héroïne IV 1 à 2 fois par mois

ATCD : Aucun
Pas d'allergie connue.

Traitements à l'entrée : Aucun

Histoire de la maladie :
Fièvre autour de 39°C depuis 4 jours. Initialement pas d'inquiétude de la famille car "tout le temps malade".
Présence depuis ce matin d'un déficit moteur de l'hémicorps droit. Sa mère le trouve confus, il a du mal à répondre lorsqu'elle lui parle. Elle le trouve aussi très somnolent.
Pas de dyspnée, pas de toux. Pas de signes fonctionnels urinaires. Pas de nausées ou de vomissements, pas de douleur abdominale, pas de diarrhée.
Appel du SAMU dans ce contexte.

À l'arrivée aux urgences :

<u>Examen général</u> :
Stable hémodynamiquement
Fièvre à 39.2°C
Présence d'adénopathies bilatérales dans les aires cervicales, axillaires et inguinales

<u>Examen neuro</u> :
GCS 13 (Y3, V4, M6)
Paralysie faciale droite
Déficit sensitivo-moteur de l'hémicorps droit
ROT perçus bilatéraux et symétriques
Réflexe cutanéo-plantaire en flexion
Nuque souple

<u>Examen cardio-respiratoire</u> : RAS

<u>Examen abdominal</u> : RAS

<u>Examen dermato /ORL</u> :
Aspect de candidose buccale

Iconographie

C’est flou désolé mais il gigotait dans la machine…

Examen biologique

GR : 4 060 000/mm3
Hb : 13,1 g/dl
Ht : 37,8%
Leucocytes : 3 200/mm3

PNN : 88%
PNN : 2 816 /mm3
PNE : *en cours*
PNE : _____
PNB : *en cours*
PNB : _____
Lymphocytes : 6%
Lymphocytes : 192 /mm3
Monocytes : 6%.
Monocytes : 192 /mm3

ECOS TACFA

GRILLE D'ÉVALUATION

Interprétation des examens	Scanner cérébral avec injection	1pt
	Scanner en coupe axiale	
	Lésion en cocarde du lobe frontal gauche	1pt
	Évoque un réhaussement périphérique de la lésion sur le scanner	
	Énonce une lymphopénie à la biologie	1pt
	Suspecte le diagnostic de toxoplasmose cérébrale	1pt
	Énonce une probable <u>infection à VIH</u> : ok si au moins 3 - lymphopénie - toxoplasmose cérébrale - candidose buccale - consommation de drogues IV - relations sexuelles multiples	1pt
	Évoque un stade SIDA (car infection opportuniste)	1pt
Stratégie de prise en charge	Hospitalise le patient	1pt
	Recherche VIH par <u>sérologie par test ELISA puis confirmation Western Blot</u> (tous les termes sont nécessaires pour avoir le point)	1pt
	Dose la charge virale VIH	1pt
	Dose la LTCD 4	1pt
	Sérologie toxoplasmose	1pt
	Discuter d'une ponction lombaire (PCR)	1pt
	Ttt toxoplasmose à débuter	1pt
	TOTAL	**/ 13**

OBJECTIFS GÉNÉRAUX		
Aptitude à faire la synthèse des données		
Insuffisante	N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	0 point
Limite	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelques fois sans les justifier	0.25 points
Satisfaisante	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	0.5 points
Très Satisfaisante	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	0.75 points
Remarquable	Agit avec assurance et sans erreur	1 point
Aptitude à proposer une prise en charge		
Insuffisante	Est incapable de proposer une prise en charge adaptée à la situation clinique	0 point
Limite	Propose une prise en charge couvrant les éléments essentiels. N'arrive pas à justifier une démarche	0.25 points
Satisfaisante	Propose une prise en charge couvrant les élements essentiels et justifie la démarche	0.5 points
Très Satisfaisante	Propose une prise en charge pertinente. Ne s'attarde pas au traitement ou à la prise en charge inutile. Justifie la démarche	0.75 points
Remarquable	Établit l'ordre des priorités des différents aspects de la prise en charge	1 point
	TOTAL OBJECTIFS GÉNÉRAUX	**/ 2**
	TOTAL	**/ 15**